

INDICADO POR: Dr. Priscila

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

ADRIANO JOSE VIEIRA 1

IDADE: 43 PESO: 120 ALTURA: 1,71 PROFISSÃO: Vendedor Camo.

SINTOMAS: Insônia mantença, apnéia noturna, desabrimos.

QUEIXAS: Garganta entada, refluxo, Ronco, sonolência diurna;

MEDICAMENTOS: Brazint (HAS).

MÉDICO: Dr. Priscila

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ NEXERCÍCIO FÍSICO: ☒ S

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S

HORA QUE DORME: 02h 02h HORA QUE ACORDA: 7h 30'

COCHILHO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N FDS.FUMO: ☒ S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: Exponedico.

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE: 1x.

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI: III

IAH: 53,81h SPO2: 81%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

língua volumosa.

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Denio Naval (fratura Antiga).

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

02/04/15. Análise. Auto 4 = 14 cmH₂O Dream Weav (S) Sleep

09/04 - P = 7.2 cmH₂O - Cefaleia a tarde (↓ de manhã)
25 IAH = 2.9 e/le - melhora da dor mmh.
m. de uso: 7h 30' ↑ a Pi = 6.5
fuga = 4' 36" ↓ a Pmax = 9.0 sua claudia

30/04 P = 7.3 cmH₂O
25 IAH = 3.0 e/le Relata que nos últimos
m. de uso: 5h 55' 15 dias surgiram
diversos problemas pessoais
fuga P = 8.5 e/le
noticia

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: **ADRIANO JOSE VIEIRA**

Sexo: **M**

Idade: **43 anos**

Peso: **120 Kg**

Altura: **1.71 m**

CA: **41.0**

Data do Exame: **21/02/2025**

Exame: **00277_01**

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:43:16 PM horas e encerrado às 5:52:01 AM horas, com latência para o sono de 1 minutos e latência para o sono REM de 347 minutos. O tempo total de sono foi de 398.0 minutos, com eficiência do sono de 92.8%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.8%	Até 5%
Estágio 2	92.5%	45 - 55%
Estágio 3	3.5%	> 15%
Sono REM	3.3%	20 - 25%
Eficiência do sono	92.8%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 30 minutos ocorreram **270 despertares (índice de 40.7 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 60 bpm, a maior de 70 bpm e a menor de 54 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 357 eventos respiratórios, sendo 0 central e 357 obstrutivos. Sendo 344 apnéias, 13 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 53.8/hora**, sendo 51.9 apnéia/hora e 2.0 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 19.0 e a duração máxima de 33.7.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 55.4/hora, sendo 55.4 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 94%**, sendo a saturação **média de 92%**, a **maior de 99%** e a **mínima de 81%**, permanecendo 31.7 minutos (7.4%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 360 dessaturações. Índice de dessaturações: 56.4/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 18.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 58.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075